

УДК:616-006.6

Б.А.Сейтказин

ГКП на ПХВ «Алматинский областной онкологический диспансер» г.Талдыкорган

ВОЗМОЖНОСТИ ПАЛЛИАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Аннотация. В статье отражена попытка разграничения в практической деятельности понятий «Паллиативная помощь» и «Паллиативное лечение», что в совокупности являются одними из составляющих обширного раздела «Паллиативная медицина» предусматривающей оказание помощи пациентам не только с онкологическими заболеваниями, но и со множеством других заболеваний. Также описан двухлетний опыт организации паллиативных коек в онкологическом диспансере, результаты их работы, возможности и целесообразность.

Ключевые слова: паллиативная помощь, паллиативное лечение, инкурабельные больные.

Неуклонный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями, установление в 50% случаев из числа выявленных распространенных (III стадия) и запущенных (IV стадия) форм, диктуют необходимость поиска наиболее приемлемых решений в лечении данных категорий пациентов. Подавляющее большинство из этих 50% - пациенты с распространенными формами III стадии заболевания. Не всем из них возможно проведение радикального лечения, но даже в случае проведения им радикальных операций, комбинированного и комплексного лечения, по сути это лечение является паллиативным, т.к. не приводит к полному их излечению. Относительно пациентов с IV стадиями злокачественного новообразования лечение однозначно паллиативное. Проведение специального лечения этим пациентам не вписывается в общепринятые стандартные схемы, например химиотерапия в индивидуальных дозах и монорежиме 1 химиопрепаратом, лучевое лечение с целью декомпрессии, гемостаза и обезболивания, циторедуктивные операции и т.д.

Материалы и методы исследования: истории болезни больных, пролеченных на паллиативных койках, электронный регистр онкологических больных, журнал регистрации пациентов паллиативных коек.

В феврале 2014 года в областном онкологическом диспансере 10 коек хирургического отделения были перепрофилированы в паллиативные койки. С момента перепрофилирования коек возникла необходимость четкого определения: как будет называться лечение на данных койках, как отбирать пациентов, будут ли выполнять эти койки функции хосписа?

Дело в том, что по классификации ВОЗ: «паллиативная помощь – это направление медицинской и социальной деятельности, целью которой является улучшение качества жизни инкурабельных больных и их семей по-

средством предупреждения и облегчения их страданий, благодаря тщательной оценке и купированию боли и других симптомов – физических, психологических и духовных».

В то же время в отношении паллиативного лечения нет каких либо стандартизованных методик и определений, хотя необходимость в этом существует. Практика показывает, что даже в IV стадии опухолевого процесса немало пациентов, которым возможно проведение паллиативного лечения как специфического так и неспецифического. До открытия паллиативных коек пациентам с IV стадией проведение специального лечения было проблематичным, так как стандартные схемы лечения большинство из них не могут перенести, а проведение нестандартных схем расценивалось как нарушение протокола. В течение 2014года определилось предназначение этих коек – проведение паллиативного лечения при одновременном оказании паллиативной помощи.

В качестве определения мы выбрали на наш взгляд наиболее приемлемое: «паллиативное лечение – это совокупность специфических лечебных мероприятий направленных на смягчение или временное приостановление клинических симптомов прогрессирующего злокачественного процесса и его осложнений».

Все основные традиционно применяемые методы лечения в онкологии –хирургический, лучевой, химиотерапевтический, гормонотерапевтический, иммунотерапевтический могут быть применены в качестве паллиативного лечения как каждый из них в отдельности, так и в комбинации, с индивидуальным подбором объемов, режимов и доз.

Порядок госпитализации определен следующим образом:

Отбор пациентов производится мультидисциплинарной группой на амбулаторном этапе, она же определяет вид и объем лечения. В стационаре пациентов ведут врачи хирургического отделения в сотрудничестве с радиологом, химиотерапевтом, психологом, социальным работником, врачом противоболевой терапии и анестезиологом (в помощь врачу противоболевой терапии на 0,5 ставки принят опытный врач-анестезиолог для оценки и купирования боли пациентам в стационаре). В результате пациенты получают и паллиативное лечение и паллиативную помощь. Также на паллиативные койки могут быть госпитализированы пациенты, которым невозможно проведение специального паллиативного лечения, но возможно проведение неспецифического (симптоматического) лечения.

Виды лечения оказываемого на паллиативных койках диспансера:

Паллиативный хирургический – оперативные вмешательства направленные на уменьшение объема опухоли, удаление единичных метастазов и рецидивной опухоли, устранение угрожающих жизни осложнений опухоли. Операции по восстановлению жизненно важных функций – дыхания, питания, отведения мочи и содержимого кишечника – так называемые «симптоматические» операции. В 2014 году операции на паллиативных койках не производились. В 2015 году на паллиативных койках произведено 7 операций. В первом квартале 2016 года – 1 операция. Сроки пребывания на койке от 7 до 14 дней, реже 15-20 дней.

Паллиативный радиотерапевтический – замедляет рост опухоли и позволяет устранить такие осложнения как сдавление жизненно важных органов, болевой синдром при деструкции костей скелета, сдавлении нервов, с целью гемостаза, а также достижения стабилизации процесса при некоторых видах местнораспространенных опухолей и единичных метастазов. В 2014 году на паллиативных койках лучевое лечение не проводилось. В 2015 году паллиативное лучевое лечение получили 121 пациент. В первом квартале 2016 года – 50 пациентов. Сроки пребывания на койке от 3 до 20 дней, при хорошем эффекте и продолжении лечения в объеме радикальной программы – до 40 дней. Суммарная очаговая доза (СОД) обычно от 6 до 20 Грей. При хорошей переносимости СОД может быть увеличено до 40-60 Грей.

Паллиативный химиотерапевтический – специфическое лекарственное лечение, направленное на уменьшение клинических проявлений заболевания, следовательно, и улучшение качества жизни. В нашей практике наблюдали улучшение качества жизни и выживание от 1 месяца до 2-х лет (в отдельных случаях): при метастатических раках молочной железы, яичников, легкого, колоректальном раке. В 2014 году химиотерапию на паллиативных койках получили 10 пациентов. В 2015 году – 42 пациента. В первом квартале 2016 года – 5 пациентов. Проведенное лечение отличалось от стандартных схем за счет индивидуального подбора. Пребывание пациента на койке от 1 до 5-8 дней.

Паллиативный неспецифический (симптоматический) – лечение осложнений прогрессирующей опухолевой болезни в виде противовоспалительной, инфузионной, гемостимулирующей терапии, парентерального питания, обезболивания, «симптоматических» операций (трахеостомии, плевральные пункции, лапароцентез, прошивание кровоточащей опухоли, наложение колостомы, энтеростомы, гастростомы, эпицистостомы), что также может привести к временному улучшению состояния и качества жизни. В 2014 году паллиативное неспецифическое (симптоматическое) лечение проведено 53 пациентам. В 2015г – 65 пациентам. В 1-м квартале 2016г – 0. Длительность пребывания на койке от 1-го до 10 дней, в некоторых случаях – до 15 дней.

Всего за 2014, 2015 и 1 квартал 2016 года пролечено на паллиативных койках 354 пациента. Из них умерло 215 пациентов. Продолжают паллиативное и симптоматическое лечение 139.

Выводы. 1) Паллиативное лечение позволяет временно улучшить качество жизни пациентов с первично выявленными запущенными формами, а также рецидивами и прогрессированием ранее пролеченных злокачественных новообразований. При этом существенного продления жизни не наблюдали.

2) На паллиативных койках возможно проведение паллиативного специфического (в онкодиспансере), неспецифического лечения и оказания паллиативной помощи (в неонкологическом учреждении).

3) Паллиативные койки не выполняют функцию хосписа.

4) Паллиативные койки необходимы не только в онкологических диспансерах, но и в городских и районных больницах, многопрофильных клиниках – для оказания паллиативного неспецифического лечения и «симптоматических» операций, как в экстренном так и в плановом порядке, а также может быть оказана паллиативная помощь согласно стандартам ВОЗ.

5) При согласовании и получении разрешения Управления здравоохранения и РЦЭЗ (на перепрофилирование коек), пациенты на паллиативных койках не будут являться «непрофильными».

**Тұжырым
Б.А.Сейтказин**

**ГКП на ПХВ «Алматылық облыстық онкологиялық
диспансер» Талдықорған қ.**

**Онкологиялық науқастадағы паллиативтік емнің
мүмкіндіктері**

Мақалада «паллиативтік көмектің» және «паллиативтік емнің» тәжірибелік тұрғыда мағыналық айырмашылығы көрсетілген. Ал ол, өз тұрғыда паллиативті медицинаның ауқымды бір бөлігі болып саналады. «Паллиативті медицина» онкологиялық науқастарға ғана емес сондай-ақ басқа да аурулары бар науқастарға көмек көрестуге негізделген.

Сонымен қатар мақалада онкологиялық диспансердегі паллиативті төсек орындардың екі жылдық тәжірибесі, жұмыстарының нәтижелері, мүмкіндіктері және оның тиімділігі көрсетілген.

Түйінді сөздер: паллиативтік көмек, паллиативтік ем, емге келмейтін (инкурабельды) науқастар.

**Summary
B.A. Setkazin**

«Almaty Regional Oncology Center» Taldykorgan

**Palliative care approaches in treatment of cancer
patients**

The article reflected the attempt to distinguish in the practical work of the concepts of «Palliative Care» and «palliative treatment», is one of the components of the extensive section «Palliative Medicine providing assistance to patients not current with oncological diseases, but with many other diseases. Also described is how the two-year experience of the palliative care in question was that the results of their work and the usefulness.

Key words: palliative care, palliative treatments